

УДК: 616.5-006-771

Г.А.Тлеугабылова

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Диагностика опухолей кожи

Аннотация. По данным онкологической службы республики Казахстан злокачественные новообразования кожи (в том числе меланома кожи) находятся на третьем месте в структуре злокачественных опухолей

Цель исследования - изучение новых возможностей диагностики невусов и опухолей кожи.

Материалы и методы. В работе использованы материалы клинических наблюдений 38 больных. Диагностика невусов и опухолей кожи больных проводилась на аппарате «Дерматоскоп» фирмы Scalar(Япония).

Таким образом, дерматоскопия позволяет оценить изменения, происходящие в тех или иных образованиях кожи при невусах и доброкачественных опухолях кожи, что дает возможность для успешной и своевременной диагностики злокачественных образований кожи. Ключевые слова: рак кожи, невус, дерматоскопия.

Актуальность

Рост заболеваемости раком кожи назван «тихой эпидемией» XX века. Рак кожи и меланома - одно из наиболее распространенных в мире онкологических заболеваний, и в ряде стран (США, Австралия) он выходит на первое место [1,2].

На сегодняшний день по данным онкологической службы республики Казахстан злокачественные новообразования кожи (в том числе меланома кожи) находятся на третьем месте в структуре злокачественных опухолей при 10,6% (10,6% - 2009 г.) и продолжают оставаться в «пятерке лидеров» в структуре онкопатологии среди населения. Показатель заболеваемости раком кожи (без меланомы) в 2010 г. составил 17,6‰ (17,5‰ 2000-2009 г.). Заболеваемость раком кожи определилась первым рангом в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, в г. Алматы, вторым рангом

- в Карагандинской и Костанайской областях, третьим - Северо-Казахстанской и в Западно-Казахстанской областях [3].

При своевременном обращении к онкологу и адекватном лечении рака кожи на ранней стадии удается полностью излечить 95% больных [1,4]. Учитывая эти обстоятельства, сохраняется актуальность ранней диагностики, профилактики доброкачественных и предопухолевых заболеваний кожи.

В 2001 г. на первой Консенсусной конференции по дерматоскопии (метод визуальной диагностики кожи с помощью видеоаппаратуры с увеличением в 40-80 и в 100 раз) были выработаны соответствующие рекомендации и определены показания для использования разработанных дифференциально-диагностических алгоритмов в клинической практике. Разработанный алгоритм позволил проводить дифференциальную диагностику меланоцитарных и немеланоцитарных, а также злокачественных и

доброкачественных пигментных новообразований кожи по характерным визуальным признакам [5].

По данным ряда исследователей выявлено, что чувствительность дерматоскопии для выявления внутрикожных метастазов составила $75,0 \pm 4,1\%$, а при осмотре через лупу, применяемом при стандартных обследованиях, $26,0 \pm 3,4\%$ ($p < 0,001$) [6,7].

Цель исследования

- изучение новых возможностей диагностики невусов и опухолей кожи.

Материалы и методы

В работе использованы материалы клинических наблюдений 38 больных, находившихся на обследовании и лечении в Казахском НИИ онкологии и радиологии с октября 2011 г. по апрель 2012 г. Диагностика невусов и опухолей кожи больных проводилась на аппарате «Дерматоскоп» фирмы Scalar(Япония). Методика неинвазивна *in vivo*, исследование кожи можно проводить в любых условиях, где есть компьютер или ноутбук. С использованием аппарата «Дерматоскоп» возможно увеличение образований кожи до 100 раз с проведением фото-видео съемки и с последующим архивированием. С помощью данного исследования определяется граница дермы и эпидермиса, сосочковый слой дермы, а также становятся видны пигментация и строение эпидермиса различных образований кожи.

Всем больным была проведена диагностика на аппарате «Дерматоскоп». Первичные злокачественные опухоли кожи были диагностированы у 8 больных (21,1%), из них с метатипическим раком у 1 (12,5%) пациентки, меланомой у 2 (25%), базалиомой у 5 (62,5%) больных. У основного большинства 18 (47,4%) пациентов из 38 диагностированы различные виды невусов кожи, у 4 (10,5%) - себорейный кератоз, у 3 (7,9 %) - дерматофиброма, у 2 (5,3%) - гемангиома, у 3 (7,9%) - диспластический невусный синдром (ДНС).

Больной С, 50 л. аппаратом «Дерматоскоп» диагностирована Меланома плеча слева по 3 основным признакам: 1 - асимметрия образования кожи по форме и пигментации, 2 - бело-голубые структуры, 3 - ромбовидные структуры с кольцевидно-зернистыми формами (рис. 1). Больному Н, 52 л. аппаратом «Дерматоскоп» диагностирована Базалиома кожи носа по 2 основным признакам: 1 - «ветвящиеся сосуды», 2 - бело-голубые пятна (рисунок 2). В обоих случаях диагнозы подтверждены морфологически.

Больной К, 18 л. с помощью аппарата удалось проинвестировать исследование при ДНС с поражением кожи спины, подмышечной области и паховой области. Папилломатозный невус кожи спины (рисунок 3) выставлен с помощью аппарата «Дерматоскоп» на основании 3 признаков: 1 - экзофитные папиллярные структуры,

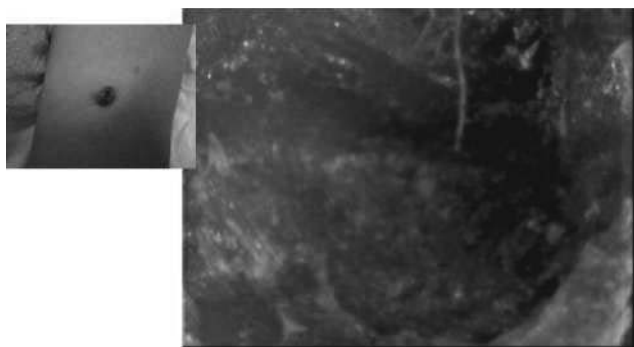


Рисунок 1 - Меланома плеча слева

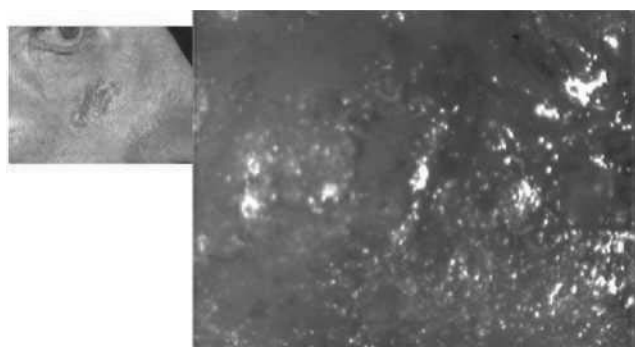


Рисунок 2 - Базалиома кожи носа

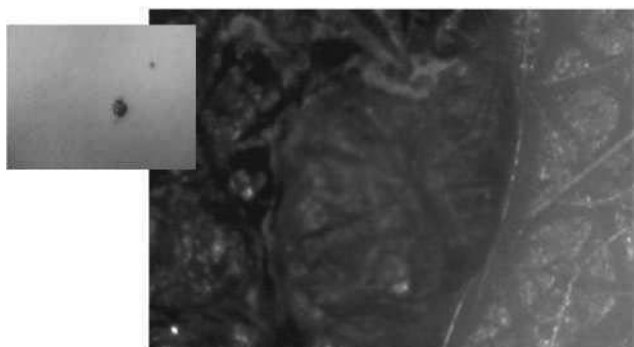


Рисунок 3 - Папилломатозный невус кожи спины

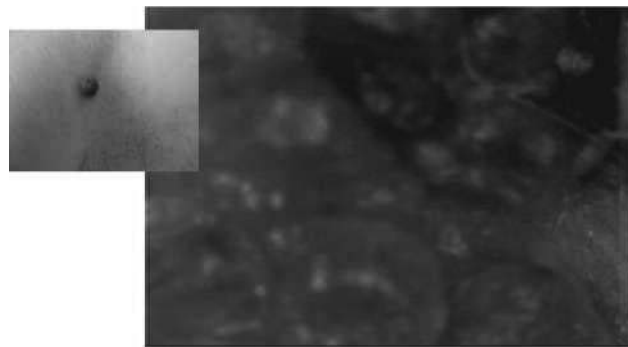


Рисунок 4 - Внутридермальный невус кожи подмышечной области слева

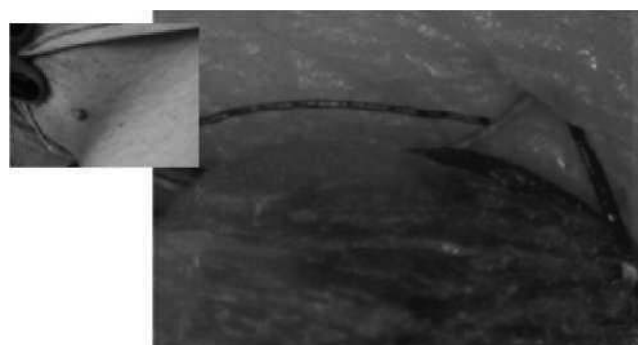


Рисунок 5 - Смешанный невус кожи паховой области справа

2 - камедон подобные отверстия, 3 - милиум-подобные кисты. Подобные образования похожи на меланому. О доброкачественной природе свидетельствует мягкая консистенция и способность сжиматься при надавливании. На рис. 4 видны признаки внутридермального невуса. Заметны участки темно-коричневых пятен и глобул с зонами гипопигментации. В центре имеется бело-голубая структура, представляющая собой пласт меланоцитов. Для исключения меланомы была показано оперативное удаление образования кожи подмышечной области слева с гистологическим подтверждением.

Этой же больной было проведено исследование правой паховой области и дерматоскопической особенностью этого образования явилось наличие экзофитных папиллярных структур, в бороздках гладкой кожи - несколько параллельных пигментированных линий, в центре - скопление темно-коричневых точек и глобул. Избыточная пигментация образования требует проведения дифференциального диагноза с акральная меланомой *insitu*. После оперативного удаления обра-

Выводы

Таким образом, дерматоскопия позволяет оценить изменения, происходящие в тех или иных образованиях кожи при невусах и доброкачественных опухолях кожи, что дает возможность для успешной и своевременной диагностики злокачественных образований кожи.

Список литературы

1. Шенталь В.В., Пустынский И.Н. Рак кожи // РЖО (клиническая). - М.: Медицина., 2001. - № 11. - С. 6.
2. Давыдов М.И., Демидов Д.В., Поляков Б.И. - Основы онкологии: Учебник. - М., 2002. - 240 с.
3. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Аймагамбетова А.Е. Показатели онкологической службы республики Казахстан за 2010 год (статистические материалы). - Алматы, 2011. - 108 с.

4. Давыдов М.И., Демидов Д.В., Поляков Б.И. Современное состояние и проблемы онкологии // Врач. - 2006. - № 13. - С. 3-5.
5. Argenziano G., Soyer H.P., Chimentietal S. Dermatoscopy of pigmented skin lesions: Results of consensus meeting via the Internet // J. Am. Acad. Dermatol. - 2003. - Vol. 48. - С. 679 - 93.
6. Балтабеков Н.Т.. Пути улучшения диагностики и лечения меланомы: дисс. докт. мед. наук. - Алматы, 2009.
7. Фрадкин С.В., Залуцкий И.В. Меланома кожи. - Минск, 2000. - С. 221

Тұжырым

Г.А.Тлеугабилова

Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты

Тері обырының ерте диагностикасы

Қазақстан Республикасында қазіргі таңда онкология қызметтері терінің қатерлі түзілістері (соның ішінде тері меланомасы) қатерлі обыр құрлымы үшінші орында тұр.

Зерттеу мақсаты – тері обыры және невусты диагностикалаудағы жана мүмкіндіктер.

Әдістер және материалдар. Клиникалық бақылауға

38 науқастың материалы қолданылған. Невус және тері обыры бар науқастарды диагностикалау мына аппаратпен жүргізіледі «Дерматоскоп» фирма Scalar (Япония).

Қатерсіз тері обыры және невустағы терінің өзге немесе өзіндегі түзілімдер, зерттеу көрсеткіштері, дерматоскопияда өзгерістерді бағалауға мүмкіндік береді және қатерлі тері түзілімдерінің заманауи диагностикасы болып табылады.

Түйінді сөздер: тері обыры, невус, дерматоскопия.

Summary

G.A. Tleugabilova

Almaty State Institute of Advanced Medical

Early Diagnosis of skin tumors

Abstract. To date, according to the Oncology Service of the Republic of Kazakhstan malignant neoplasms of the skin (including melanoma of the skin) are in third place in the structure of malignant tumors.

The purpose of research - the study of new possibilities diagnosis of nevi and skin tumors Materials and methods. The paper benefited clinical observation of 38 patients. Diagnosis of nevi and skin tumors of patients was carried out using the "Dermatoscope" firm Scalar (Japan). The study showed that dermatoscopy to evaluate the changes occurring in the various formations of the skin with nevi and benign tumors of the skin, allowing for a successful and timely diagnosis of malignant tumors of the skin.

Keywords: tumor of the skin, nevi, dermatoscopy.